格列齐特

编辑时间：2002
修改时间：2022-06-07

【药物名称】

中文通用名称：格列齐特
英文通用名称：Gliclazide
其他名称：达尔得、达美康、格列齐特Ⅱ、弘旭阳、甲磺吡脲、甲磺双环脲、金诺唐康、克里克那隆、来克胰、美齐特、圣瑞恩格列齐特、唐迪、唐清、茵平、Adianor、Diabeton、Diabezid、Diabrezide、Diamicron、Diaprel、Diclazide、Dramion、Gelieqite、Gliclazidum、Gluctam、Glymicron、Nordialex、Unava。

【药理分类】

西药 \ 代谢及内分泌系统用药 \ 抗糖尿病药 \ 促胰岛素分泌药 \ 磺酰脲类

【临床应用】

国内批准适应症

用于饮食控制、体育锻炼及减轻体重不足以控制血糖的2型糖尿病。[1]

【用法与用量】

国内批准用法用量

成人
·常规剂量
·2型糖尿病
1.口服给药（1)普通制剂：初始剂量为一次40-80mg，一日1-2次。以后根据血糖水平调整至一日80-240mg，分2-3次服用，[1]特殊病例可用至一日320mg。每次增量应间隔至少14日。[9](2)缓释制剂：推荐初始剂量为一日30mg(相当于普通制剂一日80mg)，建议于早餐时服用。根据血糖水平调整剂量，若血糖获得有效控制，维持剂量为一日30mg；若血糖控制欠佳，剂量可逐次增至一日60mg、90mg或120mg。每次增量应间隔至少1个月；但若使用某一剂量治疗2周后血糖仍无下降，建议此时增加剂量。推荐最大日剂量为120mg。[5]
·肾功能不全时剂量
1.普通制剂：肾功能不全者应以最低剂量开始使用，并谨慎增加剂量。[9]
2.缓释制剂：轻至中度肾功能不全者无需调整剂量，但应密切监测。[5]
·肝功能不全时剂量
普通制剂：肝功能不全者应以最低剂量开始使用，并谨慎增加剂量。[9]
·老年人剂量
1.普通制剂：老年人应酌减剂量。[1]
2.缓释制剂：65岁及65岁以上老年人无需调整剂量。[5]
·其他疾病时剂量
普通制剂：营养不足、身体状态有较大变化、热量摄入不规律的患者应以最低剂量开始使用，并谨慎增加剂量。[9]

【给药说明】

给药方式说明

口服给药（1)本药缓释片不应粉碎或咀嚼，60mg规格缓释片可分为两个半片。[6](2)如漏服本药缓释制剂，不得增加第2日的服药量。[5]

【禁忌症】

1.对本药或其他磺酰脲类、磺胺类药过敏者。[5]

2.严重肝、肾功能不全者。[5]

3. 1型糖尿病患者。[5]

4.糖尿病酮症酸中毒、糖尿病前驱昏迷或昏迷患者。[5]

5.哺乳期妇女。[5]

【慎用】

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者(使用磺酰脲类药可导致溶血性贫血)。[5]

【特殊人群】

儿童

儿童使用本药的安全性和有效性尚不明确。[5]

老人

老人的剂量信息参见“用法与用量”项。[5]

妊娠期妇女

妊娠期妇女使用本药的资料有限，建议妊娠期妇女避免使用本药。为降低与未控制糖尿病相关的先天性畸形的风险，妊娠前须控制糖尿病。建议妊娠期妇女或计划妊娠的妇女使用胰岛素治疗糖尿病。[5] 点击查看妊娠哺乳用药详情。

哺乳期妇女

本药可随乳汁排泄，哺乳期妇女禁用。[1] 点击查看妊娠哺乳用药详情。

特殊疾病状态

处于应激状态(如感染、外伤、手术)的患者：此类患者应改用胰岛素治疗。[1]

【不良反应】

1.代谢/内分泌系统 低血糖。[5]

2.免疫系统 皮肤过敏反应。[2]

3.肝脏 天门冬氨酸氨基转移酶升高、丙氨酸氨基转移酶升高、碱性磷酸酶升高、肝炎、胆汁淤积性黄疸。[5]

4.胃肠道 腹痛、恶心、呕吐、消化不良、腹泻、便秘。[5]

5.血液 贫血、白细胞减少、血小板减少、粒细胞减少。[5]

6.皮肤 皮疹、瘙痒、荨麻疹、血管神经性水肿、红斑、斑丘疹、大疱性皮肤反应(如Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症)、嗜酸粒细胞增多及全身症状型药疹(DRESS)。[5]

7.眼 暂时性视觉障碍。[1]

【药物相互作用】

药物-药物相互作用

1.咪康唑：

结果：合用可增强降血糖作用并可能出现低血糖症状，甚至昏迷。[5]

处理：禁止合用。[5]

2.抗凝药：

结果：本药与双香豆素类抗凝药合用可能导致低血糖，[1]且本药可能增强抗凝药的作用。[5]

处理：合用时应定期进行凝血检查，[1]可能需调整抗凝药的剂量。[5]

3.非甾体类抗炎药(尤其是水杨酸盐)、磺胺类药、单胺氧化酶抑制药、β-肾上腺素受体阻滞药、苯二氮䓬类药、四环素、氯霉素、哌克昔林、氯贝丁酯、[1]其他降糖药(如胰岛素、阿卡波糖、二甲双胍、噻唑烷二酮类药、二肽基肽酶-4抑制药、胰高血糖素样肽-1受体激动药)、氟康唑、血管紧张素转换酶抑制药(如卡托普利、依那普利)、H_2受体拮抗药、克拉霉素：[5]

结果：合用可能增强降血糖效应，导致低血糖。[5]

处理：合用时应谨慎。[5]

4.保泰松：

结果：合用可增强磺酰脲类药的降糖效应。[5]

机制：保泰松可取代磺酰脲类药与血浆蛋白结合和(或)减少磺酰脲类药的清除。[5]

处理：不推荐合用。[5]

5.达那唑：

结果：达那唑有致糖尿病效应。[5]

处理：建议避免合用。若无法避免合用，在使用和停用达那唑时，需调整本药的剂量。[5]

6.氯丙嗪：

结果：氯丙嗪日剂量高于100mg时可使血糖水平升高。[5]

机制：氯丙嗪可减少胰岛素的释放。[5]

处理：合用时应谨慎。在使用和停用氯丙嗪时，需调整本药的剂量。[5]

7.利托君、沙丁胺醇、特布他林：

结果：以上药物可使血糖升高。[5]

机制：以上药物可激动β_2-肾上腺素受体。[5]

处理：合用时应谨慎，必要时改用胰岛素。[5]

8.圣约翰草：

结果：合用可能使血糖升高。[5]

机制：圣约翰草可减少本药的暴露量。[5]

处理：合用时应谨慎。[5]

9.糖皮质激素、替可克肽：

结果：以上药物可使血糖升高，可能导致酮症。[5]

机制：糖皮质激素可降低对碳水化合物的耐受性。[5]

处理：合用时应谨慎。在使用和停用肾上腺皮质激素时，需调整本药的剂量。[5]

10.氟喹诺酮类药：

结果：氟喹诺酮类药可导致血糖代谢紊乱。[5]

处理：合用时应谨慎，密切监测血糖。[5]

药物-酒精/尼古丁相互作用

酒精：

结果：酒精可增强低血糖反应，同时可能导致低血糖昏迷发作。[5]

机制：酒精可抑制代偿性反应。[5]

处理：用药期间应避免摄入酒精。[5]

药物-食物相互作用

食物：

结果：食物不影响本药的吸收速度和程度。[5]

【注意事项】

用药警示

1.由较长半衰期的磺酰脲类药改为本药缓释制剂时，为避免药效叠加增加发生低血糖的风险，需留数日的窗口期。[5]

2.长期使用口服降糖药(包括本药)药效可减弱，该现象称为继发性失效，可能由糖尿病严重程度增加或对治疗的反应降低所致。[5]

3.本药可导致低血糖，驾驶或操作机械时应警惕，尤其是开始治疗时。[5]

不良反应的处理方法

如出现胆汁淤积性黄疸，应停药，通常停药后症状消失。[5]

用药前后及用药时应当检查或监测

应定期检测血糖、尿糖。[1]

制剂注意事项

乳糖：本药片剂可能含乳糖，遗传性半乳糖不耐症、Lapp乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良患者不应使用。[9]

【药物过量】

过量的表现

磺酰脲类药过量可致低血糖。[5]

过量的处理

1.对轻度低血糖症状(无意识丧失或神经系统体征)者，应通过摄入碳水化合物、调整剂量和(或)改变饮食来进行治疗，并进行严密监护。[5]

2.对严重低血糖(出现昏迷、惊厥或其他神经功能障碍)者，应以急症处理，立即入院治疗。[5]

3.对诊断或疑似为低血糖昏迷者，应迅速静脉注射高浓度(50%)葡萄糖溶液20ml，随后持续滴注浓度相对较低的葡萄糖溶液(10%)，滴注速度以维持血糖浓度在1g/L以上为准。应进行严密监护，并根据患者情况决定是否需要加强监护。[5]

4.本药与血浆蛋白结合牢固，透析对清除本药无效。[5]

【药理】

药效学

本药为一种磺酰脲类口服降糖药，结构中含有氮杂环，可刺激胰岛β细胞分泌胰岛素，从而降低血糖水平。本药可恢复2型糖尿病患者对葡萄糖作出反应的第一时相胰岛素分泌峰值，增加第二时相胰岛素分泌，明显增加餐后或葡萄糖诱导的胰岛素分泌反应。[5]

本药可通过两种可能与糖尿病血管并发症有关的作用机制减少微血栓形成：(1)部分抑制血小板凝聚和粘连，并减少血小板活化标记物(β-血小板球蛋白与血栓素B_2)。[5](2)通过增加组织型纤溶酶原激活物(t-PA)活性调节血管内皮纤溶活性。[5]

药动学

口服本药普通片剂后吸收迅速，3-4小时达血药峰浓度。血浆蛋白结合率为92%。[1]主要在肝脏代谢，主要代谢物(占总剂量的2%-3%)无降糖作用。随尿排出，尿中原形药物少于1%。[2]半衰期为10-12小时。[1]

口服本药缓释制剂后，6小时内血药浓度进行性升高，6-12小时达稳态。剂量低于120mg时，剂量与曲线下面积呈线性关系。按一日1次用药，有效血药浓度可维持24小时。分布容积约为30L，血浆蛋白结合率约为95%。半衰期为12-20小时。老年人的药代动力学参数无具临床意义的变化。[5]

遗传、生殖毒性与致癌性

·遗传毒性 本药的遗传毒性试验结果未见异常。[5]

·生殖毒性 (1)本药对雄性和雌性大鼠的生育力无影响。[5](2)动物试验中，未见本药有致畸性；在用药剂量为人类推荐最大剂量的25倍时，可见胎仔体重减轻。[5]

·致癌性 尚无本药致癌性的研究数据。[5]

【制剂与规格】

格列齐特片 (1)40mg。[8](2)80mg。[1]

格列齐特片(Ⅱ) 80mg。[2]

格列齐特分散片 40mg。[3]

格列齐特缓释片 (1)30mg。[5](2)60mg。[6]

格列齐特胶囊 40mg。[7]

格列齐特缓释胶囊 30mg。[4]

【贮藏】

片剂：遮光、密封保存。[1]

分散片：遮光、密封，室温保存。[3]

缓释片：密封，30℃以下保存。[5]

胶囊：遮光、密封保存。[7]

缓释胶囊：遮光、密封，不超过25℃保存。[4]

【参考文献】

1.药品说明书(2020-04-10)-格列齐特片(广东华南药业集团有限公司)
2.药品说明书(2020-12-30)-格列齐特片(Ⅱ)[华润双鹤利民药业(济南)有限公司]
3.药品说明书(2006-12-25)-格列齐特分散片(南昌弘益药业有限公司)
4.药品说明书(2015-06-17)-格列齐特缓释胶囊(桂林华信制药有限公司)
5.药品说明书(2020-11-17)-格列齐特缓释片[施维雅(天津)制药有限公司]
6.药品说明书(2018-12-24)-格列齐特缓释片(Les Laboratoires Servier Industrie)
7.药品说明书(2008-03-13)-格列齐特胶囊(重庆康刻尔制药有限公司)
8.药品说明书(2012-02-14)-格列齐特片(上海现代制药股份有限公司)
9.药品说明书(2019-12-05)-格列齐特片(Ⅱ)(天津华津制药有限公司)